

el concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual*

robert l. schalock y miguel angel verdugo 

hustings college, EEUU y universidad de salamanca (INICO)

El artículo presenta las implicaciones del uso del concepto de calidad de vida para la mejora de los servicios y apoyos a personas con discapacidad intelectual. En primer lugar, se examinan un conjunto de principios, prácticas y estándares de programas dirigidos a sustanciar el cambio organizacional y de sistemas. En segundo lugar, se plantean diez estrategias de mejora de la calidad procedentes de la investigación y experiencias aplicadas previamente, las cuales se consideran determinantes para la transformación e innovación actuales en los programas, servicios y apoyos.

Palabras clave. Calidad de vida. Servicios. Apoyos. Prácticas profesionales. Programas. Estudio teórico.



enhance services and supports for persons with intellectual disabilities.

The first section presents a

set of program principles, practices, and stan- **E** dards that are based on what the authors know about organization and

E system change, and the power of the QOL concept as a change agent. The second section, discusses ten quality improvement strategies that are **rn** based on research and experiences over the last two decades to improve performance and accountability of organizations and systems.

Keywords. Quality of life. Services. Suppotts. Program practices. Theoretical study.

el concepto de calidad de vida en 10s servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual

El concepto de calidad de vida se utiliza cada vez mas en el campo de la discapa cidad intelectual como marco para el desarrollo de servicios y la evaluacion de resultados personales. Otro articulo en este mismo numero (Verdugo, Schalock, Gomez y Arias) describe 10s pasos impli cados en la medicion de resultados perso nales relacionados con las ocho dimensio nes de calidad de vida y sus indicadores, que han sido ampliamente estudiados por 10s autores (Schalock et al., 2005; Schalock et at., en prensa; Schalock y Verdugo, 2002; Verdugo et al., 2006; Verdugo et al., 2005; Verdugo y Schalock, 2003). El proposito de este articulo es resumir como se utiliza el concepto de calidad de vida en la puesta en practica de programas que enfaticen el construc to, incluyendo su medida y aplicacion. Y esto es especialmente relevante en 10s momentos actuales de nuestro pais, en 10s cuales esta habiendo importantes transformaciones como product0 del reconocimiento del derecho a la auto no mia personal que ha materializado la nueva Ley espa iola de Promocion de la Autonomia Personal y Atencion a las per sonas en situacion de

cia a traves de la recogida sistematica de datos, el analisis de la informacion y el dependencia.

El articulo se divide en dos partes. La primera, presenta un conjunto de princi pios, practicas y estandares de progra mas, que se basan en aquello que cono cemos acerca del cambio organizacional y de sistemas, asi como sobre el poder que tiene el concepto de calidad de vida como agente de cambio. La segunda parte, mas extensa que la anterior, pre senta 10 estrategias de mejora de la cali dad, que se basan en nuestra experiencia durante las dos ultimas decadas, en la revision de la literatura, y en la capacidad de las organizaciones o sistemas para mejorar su funcionamiento y transparen desarrollo de estrategias de accion basa das en dicho analisis.

A lo largo de este articulo, calidad de vida es definida como (Schalock y Verdugo, en prensa):

"Calidad de vida es un estado deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades eticas -universales- y emicas -ligadas a la cultu ra; (c) tiene componentes objetivos y sub jetivos; y

(d) esta influenciada por factores personales y ambientales".

El concepto de calidad de vida aplicado a programas practicos

Principios de Aplicacion

Son cuatro los principios que guian la aplicacion del modelo conceptual de calidad de vida en los servicios y apoyos proporcionados a las personas con discapacidad. Estos son que la calidad de vida: (a) es multidimensional y tiene los mismos componentes para todas las personas;

(b) esta influenciada por factores personales y ambientales; (c) el uso de buenas practicas que incluye estrategias basadas empiricamente que reducen la discrepancia (o desajuste) entre las personas y sus ambientes a traves del entrenamiento en habilidades funcionales, el uso de tecnologia asistiva, el acceso a apoyos naturales y la adaptacion ambiental; y (d) el uso de apoyos

(b) esta influenciada por factores personales y ambientales; (c) se mejora con la autodeterminacion, los recursos, el proposito de vida y un sentido de pertenencia; y (d) su aplicacion debe basarse en la evidencia (Brown et al., 2004; Schalock et al., 2007).

Programas practicos

De los principios de implementacion del concepto de calidad de vida comentados surgen logicamente cuatro practicas profesionales en los programas. Estas practicas pueden ser descritas como: (a) un acercamiento multidimensional y holistico; (b) un enfoque comunitario, que es el contexto para una vida de cali-

individualizados y su ajuste o asociacion con los indicadores centrales de calidad de vida (Schalock et al., 2007). La asociacion de apoyos individualizados con las dimensiones de calidad de vida se muestra en la Tabla 1. Estas cuatro practicas profesionales proporcionan los parametros para los seis estandares de programas de calidad de vida enumerados en la Tabla 2.

Tabla 1. Dimensiones de calidad de vida y ejemplos de apoyos individualizados

DIMENSION EJEMPLOS DE APOYOS INDIVIDUALIZADOS

Desarrollo personal	Entrenamiento en habilidades funcionales, tecnologia asistiva, sistemas de comunicacion.
Autodeterminacion	Elecciones, control personal, decisiones, metas personales.
Relaciones interpersonales	Fomento de amistades, proteccion de la intimidad, apoyo a las familias y relaciones/interacciones comunitarias.
Inclusion social	Bienestar Emocional Bienestar Fisico
Derechos	Roles comunitarios, actividades comunitarias,

voluntariado, apoyos sociales. Privacidad, procesos adecuados, responsabilidades cívicas, respeto y dignidad. Aumento de la seguridad, ambientes estables, feedback positivo, previsibilidad, mecanismos de autoidentificación (i.e. espejos, etiquetas con el nombre). Atención médica, movilidad, bienestar, ejercicio, nutrición. Bienestar Material Propiedad, posesiones, empleo.

Tabla 2. Estándares de programas de calidad de vida

- La aplicación de 10s principios de calidad de vida
- El uso en 10s programas de principios basados en la calidad de vida
- La medida de resultados personales
- La demostración de fidelidad al modelo conceptual
- La vinculación entre las necesidades de apoyo evaluadas y las dimensiones de calidad de vida
- El uso de resultados personales para guiar el cambio organizacional y la mejora de la calidad

El concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual

todos 10s implica dos desarrollen un metodo estandariza do para su evaluacion, y pongan en mar cha el plan convenido de divulgacion y



Ademas de estos principios, practicas y estandares, la medida y uso de 10s resul tados personales relacionados con cali dad de vida exige un sistema de informa cion basado en la organizacion y gestio nado internamente, que proporcione informacion para aplicar las estrategias de mejora de la calidad que se presentan en la seccion siguiente. Este requerimien to exige que 10s proveedores de servicios asuman la responsabilidad de recoger y analizar datos, y que exista un compro miso comun entre el personal de la orga nizacion para asegurarse de que 10s resul tados personales estan claramente defini dos y articulados, que

implementar estrategias de accion (de ahora en adelante nos referiremos a ello como estrategias de mejora de la cali dad). El objetivo de la mejora de la cali dad es mejorar 10s resultados personales y la transparencia del programa. Las estrategias de mejora de la calidad des critas en esta seccion dependen en gran medida de 10s principios subyacentes a una organizacion de aprendizaje (Senge, 2006). Una organizacion de aprendizaje eficaz es aquella que tiene una cultura o sistema de valores (tales como calidad de vida) que apoya el aprendizaje, y tiene una estructura que permite la integra cion de nueva informacion para facilitar el cambio. Concretando mas, una cultura de

aprendizaje de la organizacion se

caracteriza por la innovacion, la confian

criterios para seleccionar resultados personales concretos son aquellos que una vez seleccionados: reflejan lo que las personas quieren en sus vidas, se relacionan con normas y principios actuales y futuros, 10s provee dores de servicios tienen algun control sobre ellos, y se pueden utilizar con el objetivo de informar sobre la calidad y

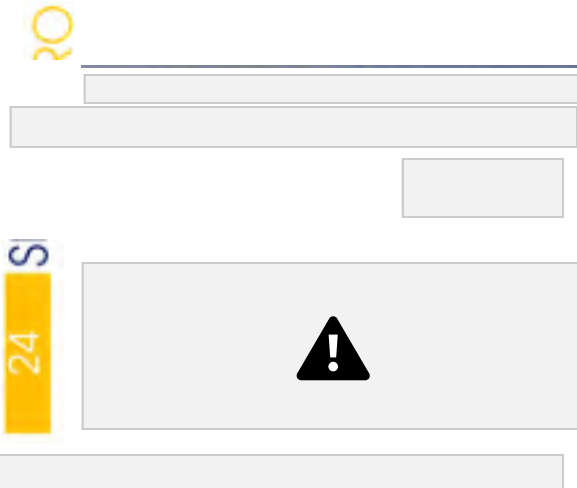
establecimien to de objetivos; su estructura se caracteri za por la colaboracion, la planificacion y la difusion (Isaacs, 1999; Lick, 2006; Orthner et al., 2006; Spector y Davidson, 2006).

Los autores de este articulo, durante las dos ultimas decadas, han participado en diversos proyectos relacionados con orga

uso (Keith y Bonham, 2005; Schalock et al., 2007). Los

za en la investigacion, y el

mejorarla. \$9 calidad:



u estrategias de mejora de la

calidad \$, ,

El concepto de calidad de vida

u n aplicado a la mejora de la

Mejora de la calidad se refiere a la capacidad de una organizacion para mejorar su funcionamiento y transparen cia mediante la recogida sistematica y el analisis de datos e informacion, y para



el concepto de calidad de vida como marco para la mejora de la calidad (Bonham et al., 2004; FEAPS, 2001; Keith y Bonham, 2005; Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, 2006; Schalock et al., en prensa; Verdugo et al., 2006). A partir de estos proyectos surgieron 10 estrategias. Estas 10 estrategias y 10s resultados perseguidos se resumen en la Tabla 3 y se tratan en mayor profundidad a continuacion.

nizaciones y sistemas que han utilizado

Tabla 3. Estrategias de mejora de la calidad y resultados

esperados Estrategias de mejora de la calidad Resultados esperados

Conseguir que las personas irnplicadas se cornprometan	de vida
Desarrollar modelos rmentales	Comprension de 10s rmodelos rmentales inhibitorios y el potencial de 10s modelos rmentales orientados a la calidad de vida
Apoyar el cambio y la transformaci61-1 Organizar	Inculcar el aprendizaje de la cultura y estructura organizacional
seminarios de analisis de datos Crear equipos de	Comprension del significado y potencial de 10s
aprendizaje	datos Aurnentar la sinergia, efectividad y eficacia
Compromiso con el modelo conceptual de calidad	
Inculcar un pensamiento "de derecha a izquierda"	Centrarse en resultados personales y en lo necesario para conseguirlos
Fornentar la redefinición de las organizaciones	Las organizaciones redefinen sus roles y funciones hacia la auto evaluaci6n y se convierten en puentes
	hacia la comunidad - S
Orientarse a la prediccion de resultados	ID. do E8
Destinar fuentes a maxirnizar el irnpacto y el resulta- i3	
Establecer estandares	Establecer criterios para mejorar el rendimiento i5g
feedback Reforzar 10s esfuerzos y el cambio, mostrar la rela- X	Evaluar el progreso y proporcionar
	cion entre las acciones y procesos y 10s resultados, 3 \$?
	proporcionar un instrumento para evaluar el rendi- O-5
	miento de la organizaci6n y para ponerse nuevos - g?
	estandares @.S

Conseguir que los implicados se
com prometan

compromiso, que
w

los resultados personales; (b) el movi-
miento del interes a1
Tu

No basta 'no'er requiere un marco conceptual de calidad 0 modelo conceptual de
calidad de vida de vida, apoyo institucional anticipado e 0 la calidad. Ademas, es

necesario conse- cambio; y (c) el movimiento del compro- d -

implicación personal en el proceso de
propuesto como base para la mejora de
guir que las personas implicadas se com- miso a la accidn, que requiere el conoci
prometan con tres tipos de transition: (a) miento de estrategias concretas, creer en
el movimiento de /a incertjdumbre a/ el valor del carnbio y desarrollar Un senti interes,
que requiere una vision, esperan- do de control personal sobre los efectos
za y respuestas posibles a como mejorar del carnbio.

el concepfo de calidad de vida en servicios y apoyos para personas con discapacidad



Los modelos mentales están fuertemente arraigados en hipótesis, generalizaciones y representaciones mentales que tenemos para comprender el mundo (Senge, 2006). Estos conforman la visión y la cultura de una organización y sirven

de base para la dirección, la formación de valores, el desarrollo de servicios, la evaluación de resultados y la mejora de la calidad. En el campo de la discapacidad, son varios los modelos mentales que han inhibido el cambio históricamente. Los principales son: (a) modelos de deficiencia, que se centran en los defectos personales más que en el potencial humano y la mejora de los factores ambientales (Devlieger et al., 2003; Schalock, 2004); (b) el excesivo énfasis en la calidad del cuidado -que se centra en el control, el poder, la salud, la seguridad, las deficiencias y la clasificación- a diferencia de la calidad de vida -que se centra en la inclusión social, autodeterminación, desarrollo personal, inclusión en la comunidad y la provisión de apoyos individualizados (de Walle et al., 2005); y (c) las organizaciones como entidades mecánicas, más que organizaciones como sistemas que se auto-organizan y refuerzan el pensamiento y la acción, la creatividad, la coordinación, el establecimiento de prioridades y los patrones de comunicación (Schalock et al., 2007). Una estrategia esencial de mejora de la calidad es identificar y conocer estos tres modelos inhibitorios, puesto que estos son con frecuencia los factores que limitan el cambio. Según plantea Senge (2006, p. 100), "para cambiar la conducta de una organización es necesario que se identifiquen y cambien los factores que la limitan y de esta forma aumentar sus capacidades". Un aspecto adicional de esta estrategia



de mejora de la calidad es hacer visibles los modelos mentales, cambiarlos y provocar los cambios dentro de una cultura que promueva la investigación y el compromiso con un modelo conceptual centrado en la calidad de vida.

Apoyar el cambio y la transformación



La mejora de la calidad implica el cambio y renovación en la planificación, la implementación y la evaluación de programas. Guiar y controlar ese proceso requiere entender los cambios que están ocurriendo dentro de los programas de educación y habilitación para personas con discapacidad, así como las estrategias de dirección y gestión requeridas para adaptarse con éxito a los

desafíos y oportunidades que provocan estos cambios. Tres cambios importantes a entender son: (a) la estructura organizativa se está volviendo cada vez menos burocrática y asociada en alguna medida con la expectativa de que la gestión conduzca a que los empleados de nivel más bajo gestionen mediante equipos de aprendizaje; (b) los procesos organizacionales están utilizando cada vez más la planificación centrada en la persona, sistemas de información y datos internos, amplia distribución de datos de su actuación, y formación directa ofrecida a todos los niveles de la organización; y (c) la cultura de la organización está teniendo cada vez una orientación más externa, capacitadora, decisiva, centrada en la comunidad, transparente y más tolerante al riesgo (Kotter, 1996; Schalock et al., 2007). Estos cambios requieren transformar el modo en que las organizaciones comunican una visión común; implican a todos los interesados; animan y apoyan el dominio personal; se centran en los niveles de sistemas (micro, meso, y macro) que afectan a los individuos, las organizaciones y los sistemas; promueven un contexto común para una vida de calidad; y miden resultados personales y utilizan esa información para múltiples objetivos, incluyendo la mejora de la calidad (de Walle et al., 2005; Gardner y Carran, 2005; Schalock et al., 2007; Schalock et al., en prensa).

Organizar seminarios de análisis de datos

En muchas organizaciones se encuentran tres realidades: primero, generalmente el personal no entiende los datos y análisis de datos; en segundo lugar, la mayoría del personal los teme debido a su frecuente asociación negativa con la evaluación y sus consecuencias potenciales.

les en relacion con permisos, financiamiento, certification o investigacion; tercero, habitualmente los datos no se han manejado de forma adecuada en el pasado, lo que afecta al modo en que la organizacion acepta la informacion y en su buena voluntad de actuar de acuerdo con ella. Por lo tanto, hemos encontrado que organizar reuniones sobre analisis de datos como estrategia de mejora de la calidad ha sido muy productivo cuando: (a) mejoran la comprension de conceptos y de diseños estadísticos de investigacion; (b) involucran a los interesados en la generacion de las preguntas de investigacion/evaluacion, en la recogida de datos y en el uso de la informacion; (c) clarifican las preguntas que se hacen a los datos, la relacion de esas preguntas con los datos analizados, y como los datos responden a las preguntas planteadas; (d) ayudan al personal a entender los factores del contexto que afectan a los resultados obtenidos; (e) proporcionan al personal indicaciones específicas sobre como se pueden utilizar los datos para mejorar resultados personales u otros indicadores de funcionamiento; (f) enfatizan que el objetivo principal de la recogida y analisis de datos consiste en mejora de la calidad no en evaluar la calidad (o la ineficacia) del programa o de los servicios proporcionados; y (g) enfatiza que cualquier evaluacion representa solamente el punto de partida y que el empleo de los

datos para la mejora de la calidad es un proceso continuo que requiere un compromiso a largo plazo.

Crear equipos de aprendizaje

Los equipos de aprendizaje se basan en el concepto de sinergia la cual se aumenta con la autodireccion, estableciendo y centrandose en metas nuevas mas ambiciosas, y pensando intuitivamente (y de forma creativa) sobre cuestiones complejas. Los equipos de aprendizaje: fomentan la codireccion del grupo; utilizan recursos de aprendizaje tales como la investigacion, la literatura, la experiencia interna y externa, los modelos de aprendizaje mas relevantes, y el desarrollo profesional; integran el conocimiento, generan las posibles soluciones y coordinan las acciones; aplican las posibles soluciones; y evalúan los resultados y comparten conclusiones a partir de las soluciones ensayadas (Isaacs, 1999; Lamase, 2006).

Inculcar un pensamiento de Derecha a izquierda

Al contrario que en las ideas tradicionales donde los gerentes se centran en las acciones que podrian conducir a los resultados deseados, el pensamiento de derecha a izquierda requiere que se especifiquen primero los resultados deseados

el concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual

(Andrews, 2004; Drucker, 1994). Una vez que los resultados deseados se especifican claramente, los implicados entonces se preguntan, "¿que se necesita en la organizacion o la comunidad para que estos resultados se den?" Los siguientes son dos

ejemplos de pensamiento de derecha a izquierda: (a) "¿que procesos (tales como planificacion centrada en la persona, apoyos individualizados concretos, y adaptaciones ambientales) son necesarios para mejorar los resultados personales?" y (b) "que factores necesitamos enfatizar -o proporcionar- para el logro de resultados personales

(i.e. jesta bleciendo metas personales y determi nando las necesidades concretas de apoyo basadas en un instrumento estan darizado de evaluacion de necesida des)?"

Animar a /as organizaciones a redefi nir sus roles y funciones

Durante las tres ultimas decadas se han producido cambios significativos en el sis tema de prestacion de servicios en disca pacidad. El mas importante ha sido el cambio desde: (a) sistemas de ayuda publica sencillos de describir e identificar para las personas con discapacidad a redes muy complejas compuestas por niveles y tipos de proveedores, escenarios y estructuras que varian ampliamente; (b) estandares y metodos tradicionales vincu lados al cumplimiento y documentacion del mismo a una metodologia de evalua cion y mejora de la calidad; (c) programas basados en la organizacion a sistemas de apoyo individualizados basados en la comunidad; y (d) organizaciones como proveedoras de servicios primarios a organizaciones como puentes hacia la comunidad (Schalock et al., 2007). Estos cambios han requerido que las organiza ciones de educacion y rehabilitacion redefinan sus papeles y funciones en la siguiente direccion: desarrollando coope racidn con otros en la comunidad; avan zando en una mentalidad de investiga cion y evaluacion, no en una mentalidad de supervision burocratica;

desarrollando y utilizando sistemas de datos internos que proporcionen informacion para las practicas basadas en la evidencia y la mejora de la calidad; usando estrategias que se centren en la reduccion de la dis crepancia entre 10s resultados personales de 10s usuarios del servicio y 10s indicado res de calidad de vida de la comunidad; y la vinculacion de 10s apoyos evaluados con la provision de apoyos individualiza dos.

Dirigirse a predecir resultados perso nales

La importancia de esta estrategia de mejora de la calidad consiste en que una vez que se identifican las variables signi ficativas que predicen 10s resultados per sonales, se pueden asignar 10s recursos para maximizar su irnpacto positivo en 10s resultados personales deseados. La Tabla 4 resume varios de 10s principales predictores de resultados relacionados con calidad de vida. De acuerdo con 10s resultados de investigacion resumidos en la Tabla 4, dos ejemplos de estrategias de mejora de la calidad potencialmente efi caces consistirian en que el personal del programa proporcione recursos y apoyos individualizados para: (a) mejorar el nivel de conducta adaptativa, estatus laboral, autodeterminacion y ayuda profesional; y (b) reducir el tamatio de 10s contextos e incrementar la disponibilidad de trans porte.

Tabla 4. Predictores significativos de calidad de vida relacionados con resultados

Variables de resultados Variables de predicci6n significativas

Puntuacion compuesta de calidad de vida Puntuaciones de CI y conducta adaptativa (Schalock et al., 1994)

Estatus vital y laboral (Schallock et al., 2000)

Nivel de autodeterminación (Wehrneyer y Schwartz, 1998)

Servicios laborales financiados por el Estado, localización geográfica, disponibilidad de transporte, patrones de dotación de personal de la empresa (Bonham et al. 2005)

Inclusión social

Relaciones interpersonales Autodeterminación

Desarrollo personal

Resultados personales

Establecer estándares

CI y nivel de conducta adaptativa (Perry y Felce, 2005; Stancliffe y Lakin, 1998)

CI y nivel de conducta adaptativa (Stancliffe y Lakin, 1998)

CI y nivel de conducta adaptativa (Perry y Felce, 2005) Tarnaiio del contexto (Tossebro, 1995)

Modelo del servicio (Walsh et al., 2006)

Tarnaiio del contexto (Perry y Felce, 2005)

Atención del personal (Emerson et al., 2001; Perry y Felce, 2005)

Cultura organizacional (Perry y Felce, 2005)

Elecciones, derechos, interacción en la comunidad, respeto, (Gardner y Carran, 2005)

Codding, 1998). Nuestro enfoque para utilizar estándares como una estrategia

Los estándares se han desarrollado y utilizado por un deseo de las organizaciones para alcanzar resultados de calidad (Centro para el Estudio de la Política Social, 1996). Aunque el enfoque utiliza lo que difiere según el área de aplicación, 10s principios clave que subyacen a 10s estándares consisten en que estos representan un punto de referencia desde el que se puede llevar a cabo la medición, un patrón con el cual otros se pueden comparar y una búsqueda disciplinada hacia buenas prácticas (Schallock, 2001; Tucker y de mejora de la calidad se ilustra en 10s dos ejemplos siguientes sobre pruebas empíricas de referencia basadas en /as puntuaciones en /as dimensiones de calidad de vida.

Desde 1998, el ARC de Nebraska, junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska, ha evaluado la calidad de vida de usuarios con discapacidad intelectual mediante ocho dimensio

nes similares a las enumeradas en la Tabla 1. Estas puntuaciones se suman para pro-

ducir un índice de percepción de bienes tar (Salud y Servicios Humanos de Nebraska, 2006; Keith y Bonham, 2005). Anualmente se divulgan las puntuaciones medias de cada dimensión y el índice de cada organización proveedora de servicios del estado, junto con la media del estado en cada dimensión, y también la media de una muestra aleatoria de personas sin discapacidad que viven en la misma comunidad que la organización proveedora. Así, hay tres estándares empíricos: uno basado en las tendencias anuales de las puntuaciones de la organización, el segundo representado por las puntuaciones medias estatales en cada dimensión, y el tercero por las puntuaciones de las personas sin discapacidad que viven en la comunidad. Cada estándar empíricamente derivado proporciona un punto de referencia y un patrón con el cual las organizaciones pueden compararse con otras que proporcionan servicios similares. La importancia del tercer estándar (referido a la comunidad) radica en que proporciona un índice de la discrepancia entre los resultados personales relacionados con calidad de vida para las personas con discapacidad y los indicadores de calidad de vida de la comunidad. Según varios autores (i.e. Schalock et al., 2007), la función de la mejora de la calidad es reducir esta discrepancia.

El segundo acercamiento a los patrones

procede del proyecto Ask Me! (¡preguntame!). Como en Nebraska, los

Perfiles de los Proveedores también

se utilizan en Maryland para divulgar las de vida de todas las

organizaciones de la puntuaciones medias anuales de calidad

comunidad (Bonham et al., 2005). Las organizaciones los utilizan con propósitos de mejora de la calidad, y en el caso de la dimensión Desarrollo Personal se utiliza por la administración del estado para desarrollar metas a nivel estatal y controlar los logros. Se han establecido dos estándares a nivel estatal o de sistemas basados en los resultados personales evaluados: mantener los porcentajes de las personas que presentan una calidad de vida positiva en las 8 dimensiones, e incrementar las medias de calidad de vida informadas al menos en una dimensión (en este caso, Desarrollo Personal).

Hay distintos instrumentos para evaluar la calidad de vida, de inminente publicación, que han sido desarrollados y validados en los últimos años en nuestro contexto, y que pueden ser utilizados como prueba de referencia para hacer evaluaciones comparativas. Entre ellos destaca la Escala Integral de Calidad de Vida (Verdugo, Gómez y Arias) que también se presenta en este mismo número de la revista, así como la futura publicación de la Escala Gencat (Verdugo, Schalock, Gómez y Arias). Asimismo, la reciente publicación de la adaptación española de la Escala

sis (Verdugo, Arias e Ibañez, 2007; Verdugo, Ibañez y Arias, 2007) para evaluar la intensidad de los apoyos es un instrumento que permite, tal como está sucediendo en otros países (Van Loon, 2006), ser utilizado como norma o estándar en los programas.

Evaluar el progreso y proporcionar feedback

Se puede dispensar feedback a dos niveles. A nivel organizacional,

por ejemplo, las puntuaciones de calidad de vida de los destinatarios de los servicios y las variables de predicción de resultados personales son discutidos por el personal de la organización. Como parte del seminario de análisis de datos en Maryland, por ejemplo, se pidió primero al personal de la organización que compararan la puntuación media de calidad de vida informada por sus usuarios con la media obtenida

Rob & L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo

nida por todos los usuarios del estado, y opinaran sobre porque sus usuarios tienen puntuaciones mas altas, mas bajas, o iguales a las del grupo de comparación. En segundo lugar, se pidió al personal que buscaran cualquier tendencia en los datos, y que relacionaran dichas tendencias con los objetivos de la organización y los cambios recientes en la provisión de servicios. En tercer lugar, se pidió a los participantes que pensarán sobre cuales serían las variables de predicción significativas y como destinarían recursos adicionales, habilidad y tiempo para intervenir sobre ellas con el objetivo de mejorar los resultados personales.

Se puede proporcionar feedback también bien a una cantidad mucho mayor de personas interesadas mediante la publicación y amplia distribución de los Perfiles de los Proveedores, tales como los descritos anteriormente de Nebraska y Maryland.

Estos Perfiles de los Proveedores tienen objetivos comunes que incluyen la evaluación del estado de calidad de vida y las necesidades de un gran número de personas, y la divulgación de la calidad de vida de los individuos atendidos por los diversos proveedores de servicios. Así, cada uno, a su propia manera, pone la información sobre la organización a disposición de los ciudadanos con y sin discapacidad en un esfuerzo para permitir un mejor acceso y toma de decisiones. La disponibilidad de estos perfiles tiene el potencial de alterar significativamente la relación entre los consumidores y los proveedores de servicios individuales. Como plantean Keith y Bonham (2005), aunque

Conclusion

El concepto de calidad de vida surgió por primera vez en la literatura sobre la capacidad intelectual en los años 80 como una noción sensibilizadora sobre lo que es importante en la vida de las personas y como un constructo social que guía la política y la práctica. Posteriormente, se ha convertido en un marco para el desarrollo de servicios y la evaluación personal de resultados personales relacionados con la calidad de vida. Debido a nuestro mejor entendimiento de la estructura del concepto y de su medida, hemos evolucionado desde la visión de la calidad de vida como un concepto hacia la calidad de vida como un constructo medible que puede proporcionar información a todas las personas implicadas en la provisión de servicios y apoyos para personas con discapacidad

intelectual y para otros colectivos con necesidades de apoyo similares.

Esperamos que este artículo contribuya a mejorar la comprensión del constructo de calidad de vida y su aplicación como base para los principios, las prácticas y los estándares de programas, y como un

marco para las estrategias de mejora de la calidad que hemos planteado en estas líneas.

Además, los autores han procurado

sensibilizar al lector sobre la

importancia de: entender la base conceptual en los programas prácticos, los resultados personales relacionados con el

funcionamiento, y aumentar la capacidad de vida como indicador principal del de las estrategias concretas

de mejora de —

dependencia se encuentra en sus de la organizacion mediante

la aplicacion

10s niveles de implicacion varian, 10s proveedores en estos dos estados han participado generalmente en estos proyectos mientras aplicaban una o mas de las 10 estrategias de mejora de la calidad que acabamos de enunciar.

la calidad.

En estos momentos en que la Ley de Promocion de la Autonomia Personal y Atencion a /as personas en situacion de

el concepto de calidad de vida en 10s servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual

el cuanto se

aporta, a quienes y a cuantos, quien lo aporta, cuando lo hace, y bajo que condiciones. Sin embargo, hemos de recordar, que sin buenas y mejores practicas la mejora de la atencion y de la calidad de vida de las personas dificilmente aumentara. Y precisamente esa mejora de la calidad de vida, en la cual coincidimos investigadores, personas con discapacidad y familiares, profesionales, gestores y politicos, es lo que se pretende con las propuestas hechas en este articulo.

momentos iniciales de aplicacion en Espatia, resulta de gran importancia pensar y planificar transformaciones e innovaciones significativas en las practicas profesionales y en la dinamica de funcionamiento de las organizaciones, servicios, programas y apoyos. Pero, hasta ahora esa preocupacion ha estado fuera del debate, tanto en las administraciones implicadas como en las organizaciones representativas de la discapacidad. Parece que solo interesa

robed l. schalock y miguel tinge1 verdugo

end: Empowerment evaluation product planning. Evaluation and

0 Andrews, A. B. (2004). Start at the Y-0

0 -- Program Planning, 27 (3). 275-285.

-- IZ Bonham, G. S., Basehart, S. y Marchand, C. B. (2005, Diciembre). Ask Me! FY 2006: The QOL of Marylanders with developmental disabilities receiving DDA funded supports. Annapolis, MD: Bonham Research.

Brown, I., Keith, K.D. y Schalock, R. L. (2004). Quality of life conceptualization, measurement, and application: Validation of the SIRG-QOL consensus principles. Journal of Intellectual Disabilities Research, 48 (Partes 4 y 5), 451.

Devlieger, J.P., Rusch, F. y Pfeiffer, D. (2003). Rethinking disability as same and different: Towards a cultural model of disability. En J.P. Devlieger, F. Rusch, y D. Pfeiffer (Eds.), Rethinking disability: The emergence of new definitions, concepts, and I

communities (pp. 9-16). Antwerp, Belgium: Garant Publishers.

De Walle, I., Van Loon, J. Van Hove, G. y Schalock, R. L. (2005). Quality of life vs. quality of care: Implications for people and programs. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 2 (3/4), 229-239.

Emerson, E., Robertson, J., Gregory, N., Hatton, C., Kessissoglou, S., Hallam, A., Jarbrink, K., Knapp, M., Netten, A. y Walsh, P. (2001). Quality and costs of supported living residences and group homes in the United

Drucker, P. F. (1994). Managing for results. New York: Harper and Row.

Kingdom. American Journal on Mental Retardation, 706, 401-415.

FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual) (2001). Manuales de buena práctica FEAPS - para/as personas con retraso mental - [También en CD-ROM y

calidad-bbpps.htm]. Madrid: Autor.

Isaacs, W. (1999). Dialogue and the art of thinking together. New York: Currency.

Keith, K.D. y Bonham, G. S. (2005). The use of quality of life data at the organization and systems level. Journal of Intellectual Disability Research, 49 (part 1 O), 799-805.

Lick, D. W. (2006). A new perspective on organizational learning: Creating learning teams. Evaluation and Program Planning, 29 (1) 88-96. Nebraska

Department of Health and

Human Services. (2006). 2006 Nebraska developmental disabilities

Nebraska's community-based service provider profiles: Information on

providers. Lincoln, NE: Author.

S
- 33 f . \$ u o o o , o (u
89 x a fil.
. a is . 2x o c ' I z , g WZ UQ
gz
Perry, J. y Felce, D. (2005).
Factors associated with
outcomes in community group
homes. American Journal on
Mental Retardation, 770 ,
121-135.

6

52

fu

5 0

Orthner, D. K., Cook, P.,
Sabah, Y. y Rosenfeld, J.
(2006). Organizational
learning: A cross-national pilot
test of effectiveness in
children's services. Evaluation
and Program Planning, 29 (1),
6-78.

Schalock, R. L. (2001).
Outcomes based evaluation
(za ed.). New York: Kluwer.

Schalock, R. L. (2004). The
emerging disability paradigm
and its implications for policy
and practice. Journal of
Disability Policy Studies, 14 ,
204- 215.

Schalock, R. L. (en prensa).
The measurement and use of
quality of life related personal
outcomes. En R. Kober (Ed.),
Quality of life for people
with intellectual disabilities.
London:
across individuals,
organizations, communities,
and systems. Washington,
DC: American Association on

Intellectual and
Developmental Disabilities.

Schalock, R. L., Lemanowicz,
J., Conroy, J. y Feinstein, C.
(1994). A multivariate
investigative study of the
correlates of quality of life.
Journal on Developmental
Disabilities, 3, 59-73.

Schalock, R. L. y Verdugo,
M.A. (2002). Handbook on
quality of life for human
service practitioners.
Washington, DC: American
Association on Mental
Retardation.

Schalock, R. L. y Verdugo,
M.A. (en prensa). Quality of
life theory: Its development
and use in the field of
intellectual disabilities. Journal
of Policy and Practice in
Intellectual Disabilities.

Schalock, R. L., Verdugo, M.A.,
Jenaro, C., Wang, M.,
Wehmeyer, M.,

perceived satisfaction.
Evaluation and Program
Planning, 23 (1), 77-88.

T; -
Springer.

Schalock, R. L., Bonham, G. S.
y Marchand, C.R. (2000).
Consumer based quality of life
assessment: A path model of

Schalock, R. L., Gardner, J.F. y
Bradley, V. J. (2007). Quality of
life for persons with
intellectual and other develop

mental disabilities:

Applications

Retardation, 170, 298-311

1.

Enhancing personal

outcomes: Organizational strategies, guidelines, and examples. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.

Xu, J. y Lachapelle, Y. (2005). A cross cultural study of quality of life indicators. American Journal on Mental Retardation, 110, 59-67.

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization (edición revisada). New York: Doubleday.

Spector, J. M. y Davidson, P. J. (2006). How can organizational learning be modeled and measured? Evaluation and Program Planning, 29 (1), 63-69.

Stancliffe, R. y Lakin, C. K. (1998). Analysis of expenditures and outcomes of Residential alternatives for persons with developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 102, 552-568.

Tucker, M.S. y Coddling, J. B. (1998). Standards for our schools: How to set them, measure them, and reach them. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Tossebro, J. (1995). Impact of size revised: Relation of number of residents to self-determination and deprivation. American Journal on Mental Retardation, 100, 59-67.

Van Loon, J. (2006). Los apoyos en Arduin. Sobre las diversas facetas de los apoyos y la implementación de la

Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) en una organización de servicios. Siglo Cero, 37 (4), 17-34.

Verdugo, M.A., Gomez, L.E., Arias, B. y Martin, J.C. (2006). Validation of the eight domain model of quality of life. Presentación en el simposio Quality of Life outcomes: Their empirical development, verification, and use. International Symposium on Social Inclusion, Montreal, CA (Mayo 2-6).

Verdugo, M.A., Ibañez, A. y Arias, B. (2007) La Escala de Intensidad de Apoyos (SIS): Adaptación inicial al contexto español y análisis de sus propiedades psicométricas. Siglo Cero, 38(2), 5-16.

Verdugo, M.A., Arias, B. e Ibañez, A. (2007). Escala de Intensidad de Apoyos - SIS Manual. Madrid: TEA. [Adaptación española de la escala original de: Thompson, J. R., Bryant, B. Campbell, E. M., Craig, E. M., Hughes, C., Rotholz, D.A., Schalock, R., Silverman, W., Tasse, M. y Wehmeyer, M. (2004). The Supports Intensity Scale (SIS): Users manual. Washington DC: American Association on Mental Retardation]

Verdugo, M.A. y Schalock, R. L. (2006) **+**

.a

(2003). Cross-cultural Survey of QOL

Indicators. Salamanca, España: Instituto Universitario de Integración de la Comunidad. Facultad de

Psicología-Universidad de Salamanca.

L.E. y Arias, B. (2007). Construcción de escalas de calidad de vida multidimensionales centradas en el contexto: la Escala GENCAT. Siglo Cero. 38 (4), 57 - 72.

Verdugo, M.A., Schalock, R. L., Keith, K.D. y Stancliffe, R. (2005). Quality of

Verdugo, M.A., Schalock, R. L., Gómez,

concepto de calidad de vida en los servicios y apoyos para personas con discapacidad intelectual

life and its measurement: Important principles and guidelines. Journal of Intellectual Disability Research, 49 (10), 707-717.

Walsh, P., Erickson, E., Bradley, V., Moseley, C. y Schalock, R. L. (2006). Quality of life report: Ireland. Dublin: Irish Department of Human Services.

Wehmeyer, M. y Schwartz, M. (1998). The relationship between self-determination and quality of life for adults with mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 31 (1), 3-12.